

Mida on õppida Hollandi kohtumääruse alusel osutatavatest tugevdatud järelevalvega teenustest?



Urve Tõnisson

käitumisekspert, koolitaja, Hoolekande Ekspertiisi ja Nõustamiskeskus

Möödunud aasta suvel Eestit külastanud suurte kogemustega Hollandi psühholoog **Tom van Son** näeb peamise erinevusena kahe riigi teenuste korralduses lisaks erinevatele võimalustele ka erinevaid arusaamu teenuse eesmärkidest: ka kõige keerulisemate probleemse käitumise juhtumite korral peaks teenus pakkuma inimesele mitte ainult järelevalvet, vaid ka mitmekülgset toetust.

Kohtumääruse alusel ööpäevaringset hoolekandeteenust osutatakse Eestis AS Hoolekandeteenused Valkla Kodus ning psühhiaatrilist sundravi SA Viljandi haiglas. Teenuste määramise kriteeriumid on ära toodud sotsiaalhoolekande seaduses ning karistusseadustikus.

SHS § 105. Isiku paigutamine hoolekandetasutusse kohtumääruse alusel

(1) Isik paigutatakse hoolekandetasutusse ööpäevaringset erihooldusteenust saama tema nõusolekuta (edaspidi nõusolekuta hooldamine), kui esinevad kõik järgmised asjaolud:

- 1) isikul on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida
- 2) isik on endale või teistele ohtlik, kui ta jäetakse paigutamata hoolekandetasutusse ööpäevaringset erihooldusteenust saama
- 3) varasemate abimeetmete rakendamine ei ole osutunud küllaldaseks või muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik.

Karistusseadustik § 86. Psühhiaatriline sundravi

(1) Kui isik on pannud õigusvastase teo toime süüdimatus seisundis või kui ta on pärast kohtuotsuse tegemist, kuid enne karistuse ärakandmist jäänud vaimuhaigeks, nõdrameelseks või kui tal on tekkinud muu raske psüühikahäire, samuti kui tal on eeluurimise või kohtus asja arutamise ajal tuvastatud nimetatud seisundid, mis ei võimalda kindlaks teha tema vaimset seisundit õigusvastase teo toimepanemise ajal ning ta on oma teo ja vaimse seisundi tõttu ohtlik endale ja ühiskonnale ning vajab ravi, määrab kohus talle psühhiaatrilise sundravi.



Tom van Son

Tom van Son on lõpetanud Hollandis Utrehti Ülikooli eripedagoogi ja psühholoogina. Hiljem on ta sundravi teemale keskendudes õppinud ka psühhiaatriat. Ta on töötanud kerge vaimupuude ja psüühikahäirega klientidega ning ka sundravi meeskondades. Ta olnud nii programmide looja kui läbiviija ning rajanud ühte haiglasse sundravi osakonna.

Praegu töötab ta konsultatsiooni- ja nõuandekeskuses (CCE, *Center for Consultation and Expertise*) eksperdina, kes annab nõu eriti keeruliste probleemse käitumise juhtumite korral.

Eestit külastades tutvus Tom van Son Harjumaal Valklas kohtumääruse alusel ööpäevaringset erihooldusteenust teenust osutava Valkla Koduga.

Mis muudab inimese nii vägivaldseks, et talle on vaja tugevdatud järelevalvega ravi- või hoolekandeteenust? Kas usute, et inimene on oma loomuselt pigem hea kui halb?

Ma ei usu, et inimloomus oleks olemuslikult halb. Laps sünnib teatud geneetiliste soodumustega, kuid ta on siiski maailma mõjudele avatud. Edaspidi vormivad teda kogemused. Kui laps kasvab stabiilses ja turvalises keskkonnas, kus tema vajadused on rahuldatud ja tema kõrval on usaldusväärsed vanemad, siis sirgub temast vastutustundlik täiskasvanu, kes suudab enda käitumist analüüsida ja oma impulsse kontrollida.

Kahjuks ei kasva kõik inimesed üles sellistes oludes. Olen lugenud paljude kohtumääruse alusel teenusele suunatud klientide toimikuid ja kuulnud nende elulookirjeldusi, need on kõike muud kui eluterved. Lapsepõlves läbielatud

negatiivsed kogemused – väärkohtlemine, hooletusse jätmine, alkoholiprobleemidega vanemad, narkootikumide kasutamine, koolikiusamine jms – jätavad sügava jälje ning mõjutavad väga tugevalt ka seda, milliseks inimeseks laps kasvab. Säärsed kogemused mõjutavalt inimese sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning enesehinnangut. Sotsiaalse arengu pidurdumine takistab nende oskuste omandamist, mida on vaja, et edukalt toime tulla sotsiaalses keskkonnas. Häirunud emotsionaalne areng seab aga piirangud enda ja teiste inimeste emotsionaalsete reaktsioonide mõistmisele. Seega muutub aga tõenäolisemaks, et inimene käitub teatud olukorras agressiivselt või kaotab oma impulsside üle kontrolli.

Samas võime kõik sattuda olukorda, millega toimetulekuks meil ei ole vajalikke oskusi ning mis võivad seetõttu osutuda (elu)ohtlikeks. Sellised situatsioonid, kus tunneme end äärmiselt abituna, võivad kergesti viia traumajärgsete stressireaktsioonideni. Kõige levinumad reaktsioonid on valikust „võitle-põgene-tardu”. Need reaktsioonid ilmnevad kõigi inimeste (ja loomade) käitumises, kui nad satuvad uudsetesse ja potentsiaalselt ohtlikesse olukordadesse. Terve psüühikaga täiskasvanutel on hoopis laiem valik toimetulekuoskusi kui inimestel, kel need oskused puuduvad ning kellel on madal enesehinnang. Madala enesehinnanguga inimesed kogevad taolistes olukordades rohkem stressi. Intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimestel on raskem toime tulla uute ja/või keerukate (sotsiaalsete) situatsioonidega. Nad käituvad säärares olukordades suurema tõenäosusega agressiivselt. Seega ei kutsu vägivaldseid reaktsioone esile mitte ainult inimene, vaid ka olukord ise. Probleemne käitumine ei ole iseloomujoon. See ilmneb kindlas kontekstis või situatsioonis. Probleemne käitumine avaldub inimese (koos kõigi tema oskuste ja puudujääkidega) ja tema keskkonna koosmõju tagajärjel.

Milline on kohtumääruse alusel osutatavate teenuste süsteem Hollandis? Kuidas selline ravi ja hooldus inimesi aitab? Ja kuidas on sellised teenused õiguslikult reguleeritud?

Hollandis on need teenused mõeldud õigusrikkujale, kes on toime pannud süüteo, mille eest neid ei saa täielikult vastutusele võtta. See kehtib nende juhtumite puhul, kui olukorra tajumist, kus õigusrikkumine aset leidis, võis mõjutada isiku psüühikahäire ja/või intellektipuu.

Kui on alust arvata, et süüalust mõjutas õigusrikkumise ajal psüühikahäire, siis tellitakse isiku vaimse tervise ekspertiisi ja selgitatakse välja, kas tema tervislik seisund ja sooritatud süütegu on omavahel seotud. Põhiküsimus on: kas inimest võib pidada süüteo eest (osaliselt) vastutavaks. Kui selgub, et isiku vaimne tervis ei mänginud süüteo sooritamisel mingit rolli, siis loetakse süüalune täielikult vastutavaks ja talle määratakse karistus. Nii võib juhtuda näiteks juhul, kus skisofreeniat põdev inimene sooritab kuriteo ajal, mil ta ei kannata parasjagu psüühhoosi käes. Kui aga selgub, et süüteo ja vaimse seisundi vahel oli seos, loetakse isik osaliselt vastutavaks või mittevastutavaks ning ta saadetakse kohtu määruse alusel teenusele. Nii võib juhtuda näiteks siis, kui isik usub psüühhoosi ajal, et tema vastas olev inimene on saatana saadik ja tahab talle halba teha. Tegelikult on süsteem muidugi palju keerulisem, meil on näiteks 21 kohtuekspertiisi artiklit eri aspektide ja ravisituatsioonide kohta.

Hollandi kohtumääruse alusel osutatavate teenuste eesmärk on ära hoida süütegude kordumine. Õigusrikkujad saavad ravi, et aidata neil hoiduda samasuguste või sarnaste süütegude toimepanekust tulevikus. Kõik programmid on loodud just seda eesmärki silmas pidades. Isegi tapmise toime pannud kurjategijate puhul on eesmärk nad siiski ühiskonda tagasi tuua, kui see on vähegi

võimalik. Kui on sooritatud raske kuritegu, mille puhul on ette nähtud enam kui nelja-aastane karistus ning võib eeldada, et teo sooritamist mõjutas ka psüühikahäire, siis võib kohtu määrusega süüalusele määrata ravi täielikult suletud, tugevdatud järelevalvega haiglas. Kohtunik hindab iga kahe aasta järel teenuseosutajate aruannete ja hinnangute põhjal inimese edusamme ja siis otsustab, kas inimene on valmis ühiskonda naasma või mitte. Kohtulikku karistust ei määrata väiksemate rikkumiste eest, näiteks kaaspatsiendi või hooldaja löömise eest. Selliste olukordadega tegeleb asutus, kelle hoole all probleemse käitumisega inimene on.

Milliseid põhimõtteid järgitakse töös kohtumääruse alusel teenustele saadetud inimestega?

Inimese käitumist on väga raske muuta, eriti juhul, kui ta on kasvanud ebasoodsates tingimustes, tal on olnud palju ebaõnnestumisi, madal enesehinnang või ta on muul moel haavatav. Ka „terve” inimese käitumist muuta pole sugugi lihtne, isegi kui inimene on selleks motiveeritud ja valmis uusi oskusi omandama. Me kõik kipume tagasi pöörduma ammu ära õpitud ja harjumuspäraste tegevusviiside (toimetulekustiilide) juurde, stressiolukordades läheme pingesse ja käiku tulevad meie stressireaktsioonid.

Kohtu määruse alusel osutatavate teenuste puhul keskendume korduvate rikkumiste ärahoidmisele. See ei tähenda kohe, et üritame muuta õigusrikkuja käitumist. Vahel tuleb üritada muuta hoopis keskkonda: näiteks elutingimusi või viisi, kuidas hooldajad inimesega suhtlevad, või leida inimesele sobivam töö. Oluline on luua sellised elu- ja tööttingimused, kus inimene tunneb end hästi ning leiab, et ta on võimeline oma elu ja igapäevaste olukordadega toime tulema. Oskuste ja ülesannete vahel tuleb luua tasakaal ja seda siis säilitada. Kui

inimesel pole vajalikke oskusi, siis õpetame neid talle. Kui inimesel on raskusi oma igapäevase elu korraldamisega, pakume talle tuge. Kui inimesel on teatud olukordades raske emotsionaalseid reaktsioone ära tunda või mõista, siis püüame leida viisi, kuidas aidata tal oma emotsioone mõista. Rehabilitatsiooniprogrammi sisu sõltub inimese psühholoogilisest seisundist, tema sooritatud rikkumise analüüsist ja riskianalüüsist.

Meie peamised tööpõhimõtted on „Hea elu mudel” (*Good Lives Model*) ja „Mis toimib põhimõte” (*What Works Principle*), need on osa RNR mudelist (*Risk, Needs and Responsivity* – riskid, vajadused ja vastuvõtlikkus).

Hea elu mudeli alusel koostame kirjelduse, milline oleks hea elu kõnealuse inimese jaoks. Aitame tal luua realistliku ja sobiva kujutluspildi sellest, millist elu ta sooviks elada. Seejärel kirjeldame vajalikke samme seatud eesmärkide saavutamiseks. Lähtume põhimõttest, et inimene, kes on oma eluga rahul, sooritab väiksema tõenäosusega kuritegusid ega muutu kergesti vägivaldseks. Programm on kombineeritud teraapiaga, selle raames töötame välja realistliku plaani eesmärkide saavutamiseks ning toetame klientide enesehinnangu paranemist.

RNRmudel eeldab programmi sellist korraldust, mille puhul edu saavutamise võimalused on maksimaalsed (st korduvad rikkumised vähenevad). Kõik Hollandi valitsuselt tunnustuse saanud kohtu määruse alusel rakendatavad rehabilitatsiooniprogrammid põhinevad järgnevatel põhimõtetel.

Risk: tuvastame tegurid, mis võivad suuri tõenäosusega esile kutsuda korduvate rikkumiste riski ning koostame plaani riskitegurite kontrolli alla saamiseks.

Vajadused: keskendume neile rikkumisega seotud teguritele, mida on programmi abil kõige lihtsam muuta või mõjutada.

Vastuvõtlikkus: koostame programmi nii, et see põhineks kõnealuse kliendi õppimiskõveral, see teeb programmi tema jaoks maksimaalselt kasulikuks.

Lisaks on veel neljaski põhimõte. *Terviklikkus*: viime programmi ellu vastavalt ettenähtule (töötame süstemaatiliselt ja teavitame tulemustest ka teisi rehabilitatsioonimeeskonna liikmeid).

Oluline on individuaalne lähenemine: noore ja intelligentse, kuid kriminaalse käitumismustriga neiu vajadused ja õppimiskõver erineb sootuks keskealise skisofreenia või intellektipuudega mehe omast. Seetõttu on tõhusa rehabilitatsiooni tagamiseks vaja suunata noor neiu teistsugusesse keskkonda kui eelmainitud mees. Tüdrukule leitakse asutus, kus ta on koos omaealiste ja samast soost kaaslastega. Tal on tarvis õppida (ja harjutada) oskusi situatsioonis, kus talle tuleb kasuks eakaaslaste seltskond. Kui neiu on näiteks kogenud seksuaalset kuritarvitamist või kui teda on peksnud purjus isa, siis oleks neiu paigutamine kohta, kus ta võiks kokku puutuda alkoholi liigtarvitajatega ja seksuaalkurjategijatega, talle kahjulik. See võib esile kutsuda reaktsiooni minevikutraumale.

Hollandis on alla 18-aastastele noortele eraldi teenused, samuti käsitletakse neid kohtuekspertiisi seadustes omaette rühmana. Eraldi teenused on ka intellektipuude ja psüühikahäirega inimestele. Inimesi saadetakse sinna vastavalt kohtuekspertiisi uuringutele ja hinnangutele ning muidugi vastavalt nende sooritatud süüteole. Arvestada tuleb ka turvalisust. Meie asutustes on neli turvaset. Vajaliku turvaseme määrab kohtunik.

Kuidas saavutate parima tulemuse? Palun kirjeldage, milliseid töömudeleid te selleks kasutate.

Uurimused näitavad, et nelja eespool kirjeldatud tööpõhimõtte alusel läbi viidud

programmi läbimisel väheneb korduvate rikkumiste arv 35%. Kuid olulised on ka programmi ellu viiva spetsialisti ja kliendi suhted. Väga tähtis on, et oleksin tõepoolest huvitatud sellest, kes mu klient on ja milliste probleemidega ta oma igapäevaelus silmitsi seisab, ja et mul õnnestuks teda mõistma panna, et teeme koostööd selle nimel, et ta ei naaseks enam kunagi vanglasse. Eesmärkide saavutamiseks tuleb koos pingutada. See ei tähenda sõpradeks saamist, spetsialist säilitab alati oma ametipositsiooni.

Edu saavutamiseks on oluline ka rikkumiste põhjalik analüüs. Tuleks kindlaks teha, millal ja kuidas klient kontrolli kaotas, ning tuvastada tegurid, mis viisid kuriteo sooritamiseni. Vaja on mõista olukorra dünaamikat. Seejärel saab tulemused kliendiga üle vaadata, et ka tema mõistaks, millised tegurid viisid kuriteo sooritamiseni.

Vaja on hinnata ja mõista kliendi elukogemusi (traumad, kasvatusviis jms), et aru saada, millised tegurid võivad käivitada emotsionaalseid või agressiivseid reaktsioone (võitlemine, põgenemine või tardumine). Töötada tuleb süstemaatiliselt ja edusamme on vaja järjepidevalt analüüsida koos kõigi meeskonnaliikmetega.

Kuidas korraldate riskianalüüsi ja hindamist? Mida ja kuidas tuleks mõõta?

Tähtis ei ole ainult riskide hindamine. Vaja on koostada riskijuhtimiskava, mis hõlmab kõiki tuvastatud riskitegureid. Näiteks kui klient on lapsepõlves korduvalt kogenud seksuaalset kuritarvitamist ja need olukorrad on olnud hirmutavad, avaldub tal sarnasesse olukorda sattudes tõenäoliselt stressireaktsioon. Tõenäosus, et selline inimene saab ise samuti seksuaalkurjategijaks, on suurem. Selliste olukordade tuvastamine on rehabilitatsiooniprogrammi koostades otsustava tähtsusega. Tuvastada tuleks ka kaitsetegurid,

mis aitavad vältida korduvaid rikkumisi. Kaitseteguriks võivad olla olulised inimesed kliendi isiklikus suhtlusvõrgustikus, hea töökoht, meeldiv eluase jne.

Riskide hindamiseks kasutame mitmeid tõendus põhiseid hindamisvahendeid. Pärast riskitegurite tuvastamist analüüsime, kuidas riskid on omavahel seotud, kuidas need võivad mõjutada inimese käitumist ning kas need saavad ajendada vägivallategu või kuritööd. Töötame läbi stsenaariumid, mis võivad teoks saada siis, kui esinevad teatud riskitegurid. Näiteks kui teame, et inimesel on probleeme raha kasutamise (ta ei mõista raha väärtust, ta ei oska arvutada või kipub esinema kellegi teisena jne), tal on väga väike sotsiaalne võrgustik (pole kedagi, kes teda jälgiks või kellelt abi küsida), tal on raske stressiga toime tulla, ta on varem varastanud või olnud lähedaste suhtes vägivaldne, sellistel juhtudel töötame välja kõiki neid tegureid arvestava plaani, kuidas vältida korduvaid rikkumisi.

Kuidas toetate oma töötajaid? Millist ettevalmistust on vaja selles valdkonnas töötavalatel õdedel, hooldustöötajatel ja spetsialistidel?

Kohtu määruse alusel teenuseid pakkuv asutuses on töötajate turvalisus isegi paremini tagatud kui tavalises psühhiaatriaiglas. Võin seda kinnitada, sest olen mõlemat tüüpi asutuses töötanud. Ohutust ei suurenda ainult turvanõuded, väga kasulikud on töötajate regulaarsed riskiarutelud. Klientide ja töötajate suhetes ei ole kohta naiivsusele. Oluline on korrapäraselt jälgida ja hinnata hoolealuste käitumist erinevates (sotsiaalsetes) olukordades ja kõrvutada seda riskianalüüsi tulemustega – see võimaldab varakult märgata võimalikke ohtlikke stressireaktsioone.

Loomulikult on väga oluline ka töötajate ettevalmistus. Lisaks psühhiaatriaõdedele ja hooldajatele kuuluvad meeskonda veel

psühhiaater, kes koostab raviplaani ja hindab selle elluviimist; psühholoog ja mitmed terapeutid. Töötajatel on erinev taust: nad on varem töötanud intellektipuudega inimestega, psühhiaatria valdkonnas või vanglates. Psühholoogina olen koos psühhiaatriga vastutanud rehabilitatsiooniprogrammide eest. Suure osa minu tööst moodustaski programmi rakendamine ja koordineerimine ning edusammude hindamine ja analüüs. Edusamme jälgivad töötajad ja hooldajad. Tegime tihedat koostööd. Probleemidega tuldi minu juurde ja me leidsime koos lahenduse. Meie suhted ei olnud hierarhiliselt määratletud. Kõigil olid oma ülesanded, kuid me töötasime meeskonnana.

Peaaegu kõigis kohtu määruse alusel teenuseid osutavates asutuses on palgal ka patsiendiesindaja, kes vastutab kliendi õiguste tagamise eest. Kõiki õigusi on selgitatud kas seaduses või asutuse tegevuseeskirjas. Sõltumata kinnipidamistingimustest saab patsiendi esindaja temaga alati kohtuda.

Külastasite eelmise aasta suvel Eestit. Milline mulje Teile jäi ja mida peaksime parandama kohtumääruse alusel osutavate teenuste valdkonnas?

Käisin Eestis esimest korda, see oli väga hariv ja väärtuslik kogemus. Mõistsin, et Hollandis oleme asutuste hulga ja taseme poolest teist oluliselt paremas seisus. Loomulikult on meil ka palju rohkem elanikke (17 miljonit võrreldes Eesti 1,4 miljoniga). Kuid erinev ei ole ainult asutuste hulk, vaid ka nende

mitmekesisus. Meie süsteemi on kujundanud kultuuriline taust ja ajalugu.

Peamine erinevus, mida märkasin rääkides inimestega Valkas ja Tallinnas, seisneb kohtumääruse alusel osutatavate teenuste süsteemi aluseks olevates arusaamades. Meie usume, et hoolitsus, olgu inimesed saadetud teenusele kohtumäärusega või mitte, ei seisne ainult käitumise kontrollimises, vaid ka klientide toetamises ja julgustamises, et see aitaks neil oma eluga edukamalt toime tulla. Paremu elu vähendab stressi ning seeläbi ka vägivalda ja kuritegevuse tõenäosust.

Hollandi spetsialistidel on kindel nägemus sellest, mida tahame oma süsteemi ja klientidega saavutada, kuidas tegutseda vägivaldse ja kuritegeliku käitumise korral ja kuidas on vaja toimida riskide vähendamiseks. Selline arusaam ongi kõige aluseks, kuid valitsus peab seda toetama. Andma küllaldast rahastust, nüüdisajastama seaduseid, koolitama töötajaid, rajama vajalikke asutusi jne. Ilma tugeva õiguse ja tervishoiusüsteemita on see väga raske.

Eestis ei ole küll veel vajalikku vundamenti, kuid sellised teenused peaksid ka Eestis olema mitmekesisemad. Intellektipuudega klientide vajadused erinevad dementsussündroomiga eakate, psühhootilisi episoodide kogevate skisofreeniaga klientide ja sensoorse informatsiooni töötlemise probleemidega autistlike klientide vajadustest. Kuid kõiki eelmainitud ühendab tõsiasi, et tähenduslikud suhted, mõtestatud tegevus ja töö, mis paneb end pädevana tundma, aitaksid neil inimestel eluga palju paremini toime tulla. S